Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Viamão

Rua Bento Gonçalves, 90 - Bairro: Centro - CEP: 94415700 - Fone: (51)3098-5599 - Email: frviamao2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000504-36.2023.8.21.0039/RS

AUTOR: DIOGO DE LEMOS PEREZ
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RÉU: MUNICÍPIO DE VIAMÃO / RS

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

DIOGO DE LEMOS PEREZ, representado processualmente pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ingressa contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e o **MUNICÍPIO DE VIAMÃO,** todos qualificados nos autos, com uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência. Assinala que possui 18 anos de idade, consoante se depreende de seu documento pessoal e, segundo laudo médico, é portadora de "Neoplasia Maligna do Encéfalo – CID 10 C71.9". Em razão de tal patologia, necessita de forma urgente do medicamento Temozolomida 20mg, 4 comprimidos por dia por 5 dias, a cada 28 dias, mais Temozolomida 100mg, 3 comprimidos por dia por 5 dias, a cada 28 dias, pelo período de 12 meses. Ocorre que o autor não possui condições financeiras de arcar com os custos de tal medicação, o qual fica em torno de R$ 7.436,06 (sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e seis centavos) mensais, conforme o menor orçamento em anexo, da Farmácia Panvel. Assim, o valor anual para o tratamento é de cerca de R$ 89.232,72 (oitenta e nove mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos). Aduzindo que o direito à saúde é dever do Estado, nos termos dos arts 6º e 196 da CF/88 e 241 da CE, postula sejam os réus compelidos, inclusive em antecipação de tutela, a disponibilizar o medicamento. Com pedido de assistência judiciária gratuita. Dá à causa o valor de R$ 89.232,72 (oitenta e nove mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos).

O e-NATJUS lança nota técnica (evento 9, NOTATEC1).

O juízo deferiu o pedido liminar (evento 11, DESPADEC1).

Citados ambos os réus, que contestam, sendo que o MUNICÍPIO DE VIAMÃO argui a incompetência do juízo, a denunciação a lide e o chamamento ao processo, diante da partilha das responsabilidades entre os entes públicos gestores do SUS, e a violação do princípio constitucional da isonomia, referindo que o fármaco tem alto custo, que não tem previsão orçamentária pelo Município, bem como a ausência de responsabilidade para o custeio, postulando a acolhida das preliminares e a improcedência da ação (evento 19, CONT1).

Por sua vez, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assinalando, de acordo com o Tema 793 do STF, a necessidade de inclusão da União na ação, com a remessa dos autos à Justiça Federal, conforme art. 109, I, da CF/88, reiterando, no mérito, o não atendimento do caso ao Tema 106 do STJ. Pugna pela necessidade de apresentação de receituário médico atualizado a cada seis meses pela parte autora. Referiu que a prescrição do medicamento seja balizada pela denominação comum brasileira, nos termos do art. 3º da Lei 9787/99. Diz ser descabida a condenação do Estado no ônus sucumbencial, quanto aos honorários pela confusão entre credor e devedor, patrocinada a ação pela Defensoria Pública do Estado, e quanto às custas processuais, pela isenção legal prevista no art. 11 da Lei Estadual 8.121/85, com a redação da Lei Estadual 14.634/2014 (evento 55, CONT1).

O Ministério Público opina, ferido o mérito, pela procedência do pedido (evento 164, PROMOÇÃO1).

II - RELATÓRIO

PRELIMINARES. TEMA 793.

É de ser afastada a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública de Viamão para processar e julgar esta causa, cujo valor foi fixado em R$ 89.232,72 (oitenta e nove mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), acima dos 60 (sessenta) salários-mínimos estabelecidos no art. 2º da Lei 12.153/09, confirmando-se a competência do juízo.

Não é caso de remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto a responsabilidade dos entes públicos é solidária, conforme arts. 6º, 23, II, e 30, VII, da CF/88 e art. 241 da Constituição Estadual, cabendo somente o repasse posterior de verba compensatória pela União relativamente ao tratamento.

Sucede que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema repetitivo n.º 793 (RE n.º 855178 RG), 16.03.2015[1], ao contrário do que alega a parte contestante, **não criou a obrigação de chamamento da União à lide, tendo reafirmado tão só a responsabilidade solidária dos entes públicos, na fixação da tese de que a responsabilidade em demandas que envolvem o direito à saúde é solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.**

Na sequência, em sede de complementação, em embargos de declaração, julgado em 23.05.2019, com a publicação do acórdão em 16.04.2020, restou sedimentado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ED no RE 855.178 se, Relator(a): Min. Luiz FUX, julgado em 23.05.2019, public 16.04.2020) (grifei)

Logo, não há falar em afastamento da solidariedade dos entes públicos, tendo a Corte Suprema apenas reafirmado a tese anteriormente defendida de que:

> *"eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles".*

No sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. TEMA REPETITIVO Nº 793 DO STF. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER. MIELOMA MÚLTIPLO (CID N18). BORTEZOMIBE 3,5MG. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELO ENCAMINHAMENTO DA AUTORA AO CACON/UNACON OU O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO POSTULADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema repetitivo nº 793 (RE nº 855178), não criou a obrigação de se chamar a União à lide. Para a devida aplicação do referido precedente deve ser analisada a matéria ali em discussão, ou seja, se a União era legítima ou não para figurar no polo passivo. Desta forma, a Suprema Corte, ao julgar o Tema repetitivo nº 793, apenas reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Seria contraditório a Corte Suprema reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e ao mesmo tempo determinar o direcionamento da ação para a União. 2. A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico. 3. A ausência de inclusão dos medicamentos em listas prévias, quer referente a remédios considerados excepcionais, quer relativos à rede básica, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados. Da mesma maneira, a forma de organização do SUS não pode obstaculizar o fornecimento de medicamentos. 4. Comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever dos entes públicos encaminhá-la ao CACON/UNACON para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de saúde e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF. Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá aos réus custearem o tratamento da parte autora. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083790402, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22-04-2020)*

O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

O processo, cujo mérito envolve questões fáticas e jurídicas, contendo documentos suficientes à solução da lide, impõe ser julgado antecipadamente, nos moldes do art. 355, I, do CPC.

Cumpre ser observado que o réu não impugnou na respectiva peça de contestação a hipótese diagnóstica da autora, acometida pela patologia classificada como "Neoplasia Maligna do Encéfalo – CID 10 C71.9".

Logo, é totalmente despicienda, no caso concreto, a realização da prova pericial, sobretudo porque não há litígio entre as partes relativamente ao diagnóstico e à eficácia da medicação requestada, **fatos estes tidos como incontroversos**.

MÉRITO

PATOLOGIA DA PARTE AUTORA. O FÁRMACO.

O medicamento postulado na petição inicial TEMOZOLOMIDA tem indicação aprovada para o tratamento de "Neoplasia Maligna do Encéfalo – CID 10 C71.9".

No caso específico, veio aos autos a nota técnica do e-NATJUS, que desaconselhou o medicamento ante "a ausência de elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de Temozolomida no presente caso".

O LAUDO juntado com a inicial, contudo, confirma a patologia e a necessidade da medicação (evento 1, LAUDO3).

TEMA 106 DO STJ.

Para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, há necessidade de atendimento ao Tema 106 do STJ, cuja tese firmada é a seguinte:

> *A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.*

Pelo laudo juntado, atendendo ao Enunciado 12 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ, expressa-se a inefetividade dos medicamentos disponibilizados pelo sistema SUS, inexistindo outro fármaco que lhe possa substituir.

Confira-se:

A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico, que indique e descreva as normas éticas, sanitárias e farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base na medicina de evidências (STJ, Recurso Especial nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção Cível – julgamento repetitivo dia 25.04.2018 – Tema 106), (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária finalizada no dia 19 de abril de 2023, referendou, por unanimidade, decisão liminar do Ministro Gilmar Mendes, que estabeleceu os parâmetros da atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema n.º 1.234:

"(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021)."

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 12 de abril de 2023 (acórdão publicado em 18 de abril de 2023), ao julgar o Incidente de Assunção de Competência n.º 14, pacificou o entendimento de que:

"(...) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080 /1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal."

Ademais, a documentação juntada demonstra a ausência de condições financeiras da parte autora.

Como se depreende do acórdão, cuja ementa abaixo se transcreve, o medicamento TEMOZOLOMIDA tem sido utilizado no tratamento médico da patologia:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DO CÉREBRO. DIREITO EVIDENCIADO. RE 1366243. TEMA 1.234 DO STF. TEMOZOLOMIDA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO NÃO PADRONIZADO. 1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, liminarmente, no Tema 1.234: a) no que tange às ações judiciais que envolvam fornecimento de fármacos não incorporados pelo SUS, estas deverão tramitar regularmente no juízo de origem (estadual ou federal), expressamente vedada a declinação de competência ou inclusão da União no polo passivo; b) em relação aos medicamentos padronizados, os processos que tiveram sentença proferida até 17/04/2023 (data da decisão liminar do Em. Ministro) igualmente devem permanecer no ramo do magistrado sentenciante até seu trânsito em julgado; c) quanto aos mesmos medicamentos padronizados, nas ações que não tiveram sentença prolatada até 17/04/2023, a composição do polo passivo deverá observar a repartição de responsabilidades estruturadas do SUS, mesmo que isso importe em deslocamento de competência. 2. O direito à saúde decorre de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. 3. O tratamento oncológico requerido nos autos não consta na lista de dispensação pelo SUS, logo, vedada a declinação de competência ou inclusão da União, em sintonia ao Tema 1234 do STF. 4. Nesse aspecto, a existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia – UNACONs, não tem o condão de afastar a obrigação dos de providenciar os procedimentos e medicamentos com a rapidez e eficiência necessária. 5. O caso envolve tratamento especializado oncológico indicado para a patologia da autora, porém não consta no Rename 2022. Assim, conforme a recente decisão da Suprema Corte (Tema 1234), impõe-se a manutenção da sentença a quo, com o reconhecimento da legitimidade passiva da parte demandada para fornecer o tratamento oncológico pleiteado. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 52633148020238210001, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 25-09-2024).

De conseguinte, se afigura inadmissível que os réus se recusem a fornecer o tratamento, sob o argumento da ausência de protocolo ou do alto custo medicação, havendo recomendação para a patologia cuidada nos autos através de laudo médico fundamento.

A prescrição do medicamento constitui ato médico que, em razão dessa assertiva, não pode sofrer direcionamento ou restrição, seja de natureza legal ou administrativa.

O alto custo do medicamento ou a circunstância de não constar das listas, ou protocolos administrativos de dispensação pelo SUS não exime os entes demandados de fornecê-lo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ART. 273 DO CPC. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há confundir decisão contrária aos interesses da parte com inexistência de prestação jurisdicional. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. ***3. O argumento de que a medicação solicitada pelo autor "não consta da lista medicamentos pertencentes ao denominado Grupo 02, de responsabilidade dos Estados e Distrito Federal, segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.981/2009, que aprova o componente especializado de assistência farmacêutica (distribuição de medicamentos do SUS)," também não encontra***

amparo neste Tribunal, pois não tem a faculdade de eximir o Estado da obrigação, imposta pela ordem constitucional, de assistir aqueles que, como a recorrida, não dispõem de recursos financeiros para custear o tratamento da própria saúde.4. Quanto à apontada falta de verossimilhança de alegações a sustentar o deferimento de tutela antecipada, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apreciação dos requisitos de que trata o artigo 273 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela antecipada, enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.6. Agravo Interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1606408/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) – grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON COM METÁSTASES HEPÁTICAS. MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: CETUXIMABE. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FÁRMACO DE ALTO CUSTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC. - O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. - ***O alto custo da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à saúde dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.*** *- Presentes os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, deve ser mantido o deferimento do pleito antecipatório. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES CASO DESCUMPRIDA A DECISÃO JUDICIAL. - Há concordância majoritária sobre a possibilidade de bloqueio de valores junto às contas dos entes públicos, caso os entes públicos se neguem a cumprir a decisão e assegurar o tratamento adequado. Aplicação direta do § 3º do art. 461-A e do § 5º do art. 461, ambos do Código de Processo Civil. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO. - Análise do pedido de manifestação da parte autora sobre a possibilidade de substituição da medicação por substâncias alternativas disponíveis na rede pública de saúde por esta Corte que ocasionaria supressão de um grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70068529304, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 04/03/2016) – grifei.*

Salienta-se que a ação foi ajuizada anteriormente ao TEMA 1234 do STF e que à data do ajuizamento da presente demanda, a jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 106 do STJ, amparava o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando evidenciada a necessidade do tratamento e a ineficácia de alternativas oferecidas pelo sistema público.

NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO SEMESTRAL DOS LAUDOS COM PROVA DE VIDA.

Como se trata de medicamento de alto custo em patologia de alta complexidade, deve a parte autora, **na falta comprovada da medicação em estoque**, apresentar atestados médicos atualizados que comprovem a necessidade e a eficácia do fármaco, conforme a fase da doença, no tratamento em progressão, presumindo-se a desistência no cumprimento em caso de não atendimento.

No sentido, o Enunciado n.º 02 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde de 18.03.2019.

ENUNCIADO n.º 02

Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Desta forma, tendo em vista a necessidade e urgência na realização do tratamento médico pela parte autora, que corre risco de morte pela gravidade da doença, o fornecimento do medicamento solicitado pelos réus é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO:

(i) JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para, confirmando a medida liminar, condenar os réus na obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento Temozolomida 20mg, 4 comprimidos por dia por 5 dias, a cada 28 dias, mais Temozolomida 100mg, 3 comprimidos por dia por 5 dias, a cada 28 dias, pelo período de 12 meses, enquanto se fizer necessário, pelo princípio ativo, de acordo com a denominação comum brasileira, nos termos do art. 3º da Lei n.º 9.787/99, devendo ser fornecida, em cada disponibilização, a quantidade suficiente para 03 (três) meses de tratamento.

(ii) DECLARO, ainda, para nova solicitação de bloqueio, na falta comprovada da medicação em estoque, deverá a parte autora a apresentar relatório médico circunstanciado, com validade para seis meses, nos termos do Enunciado 2 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, acerca da necessidade de manutenção do tratamento, com <u>prova</u> <u>de</u> <u>vida</u>.

Sem condenação do ESTADO nos honorários face à confusão entre credor e devedor.

Condeno o MUNICÍPIO ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios em favor do FADEP, a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão do trabalho realizado pelo Defensor e o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza da causa. Para a correção, aplica-se o IPCA (REsp 1.270.439/PR) a título de índice de correção, a contar da publicação desta decisão, juros moratórios aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97).

É caso de remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC, e da Súmula 490 do STJ, já que a condenação é superior a 100 (cem) salários-mínimos.

Registros e intimações eletrônicas agendadas.

Com o trânsito em julgado, efetue-se a baixa definitiva.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO EDEL LIGORIO FAGUNDES, Juiz de Direito**, em 21/01/2025, às 15:34:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10075170273v5** e o código CRC **40d032bb**.

---

1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) ↩